Doença Diverticular Complicada: Antibióticos, Drenagem e Cirurgia

Decisão pela gravidade clínica, pela TC e pela resposta ao tratamento entre antibióticos, drenagem percutânea e cirurgia — anastomose primária, Hartmann e lavagem

APRESENTAÇÃO	Natan Buono Rainho (R1 – HGU)
ORIENTAÇÃO	Dr. Manoel Antonio Ramos Neto
PROGRAMA	PRM Cirurgia Geral — Hospital Santa Rosa e HGU / Hospital Santa Helena · Secretaria Municipal de Saúde
DATA E LOCAL	18 de janeiro de 2027 · Cuiabá-MT
ARTIGO-BASE	Antoniou SA et al. EAES rapid guideline – with ESCP participation. Surg Endosc. 2025 [1] · Huo B et al. IPD network meta-analysis. Surg Endosc. 2025 [2]

Quatro perguntas orientam a aula

1 Em abscesso diverticular Hinchey Ib–II, quais achados justificam antibióticos isolados versus drenagem percutânea, e quão confiável é o limiar de 3–4 cm?

Seção 2 · resposta na seção 6

2 Em peritonite purulenta, quando a lavagem laparoscópica é aceitável e quais critérios devem fazê-la ser abandonada?

Seção 3 · resposta na seção 6

3 Como selecionar entre anastomose primária, com ou sem ileostomia de proteção, e procedimento de Hartmann?

Seção 4 · resposta na seção 6

4 Após resolução não operatória de abscesso, a ressecção eletiva deve ser rotineira ou individualizada?

Seção 5 · resposta na seção 6

Mensagem A TC classifica, a fisiologia escolhe a ferramenta e a resposta ao tratamento julga a escolha.

Ref.: [1, 2]

Uma mulher de 62 anos chega com dor na fossa ilíaca esquerda e febre: o que decidir?

CASO DIDÁTICO · ABERTURA

PACIENTE	Mulher, 62 anos, hipertensa, sem imunossupressão; estável
QUADRO	3 dias de dor em fossa ilíaca esquerda; febre de 38,6 °C
LABORATÓRIO	PCR 190 mg/L (> 173: previu Hinchey > Ib) [5]

Que exame? Antibiótico, dreno ou cirurgia? E depois?

MENSAGEM

Caso construído com dados das fontes; volta em três pontos.

Ref.: [2, 5]

Sumário

1 Do divertículo à TC

2 Abscesso: antibiótico ou dreno

3 Peritonite purulenta e lavagem

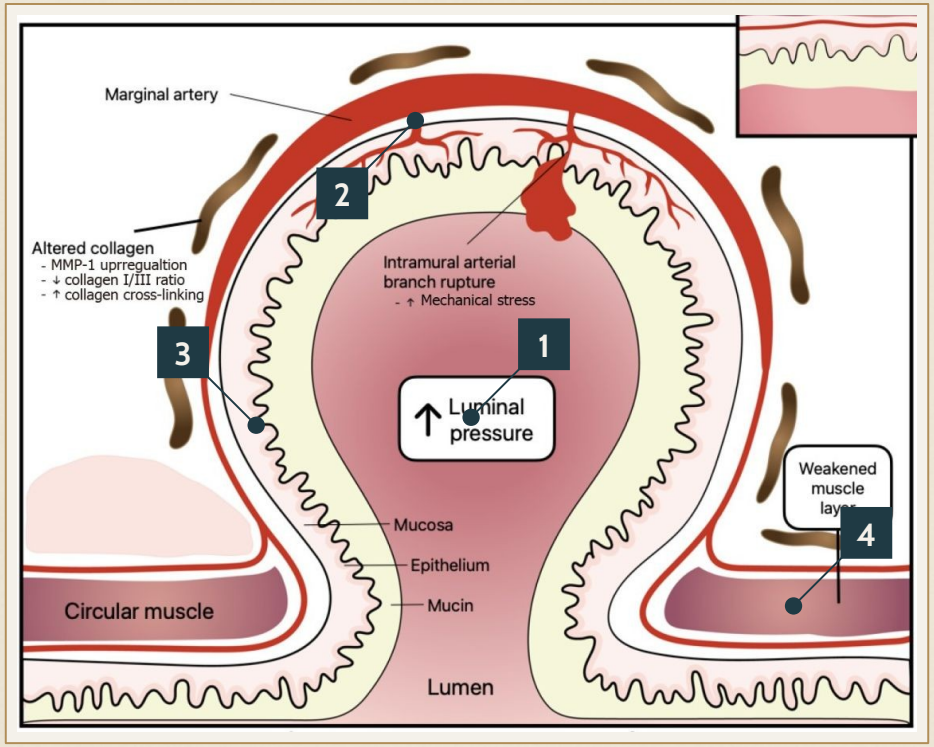
4 Anastomose primária ou Hartmann

5 Depois do abscesso

6 Respostas e forja

Mensagem Ordem do raciocínio: classificar, tratar o abscesso, operar a peritonite, decidir o depois.

Na mesa: o divertículo é falso e nasce onde o vaso reto atravessa a muscular



Corte transversal da parede: luz embaixo, serosa em cima; esquema de divertículo jejunal (mesmo mecanismo do sigmoide)

1. Pressão intraluminal empurra a mucosa
2. Vaso reto atravessa a muscular: ponto fraco
3. Mucosa e submucosa herniadas, sem muscular própria
4. Muscular circular termina no colo

Mensagem Mesmo mecanismo no sigmoide, onde estão a maioria dos casos no Ocidente [5, 37].

A doença complica em degraus, e cada degrau tem um nome na classificação de Hinchey

1
Inflamação além da parede
Confinada ao pericólon: gás pericólico ou fleimão (Ia) [5, 8].

→

2
Abscesso
Pericólico (Ib) ou pélvico/distante (II); 15–20% das internações [5].

→

3
Peritonite purulenta
Pus difuso na cavidade: Hinchey III [5].

→

4
Peritonite fecal
Conteúdo fecal livre: Hinchey IV [5].

Mensagem O degrau escolhe a ferramenta: antibiótico, dreno ou cirurgia.

Ref.: [5, 8]

A escala WSES gradua pela TC; o Hinchey modificado separa o abscesso pelo local

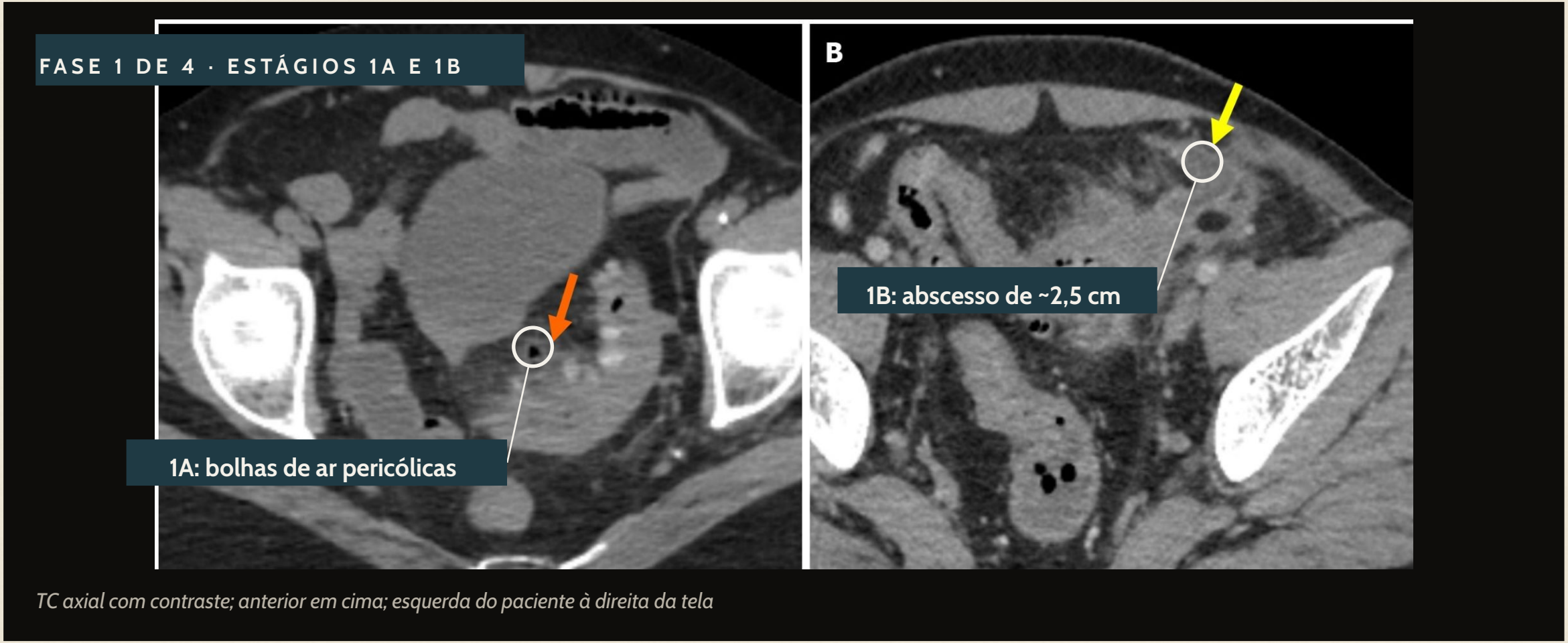
WSES (TC) [5]	Achado na TC	Hinchey modificado ≈ [8]
0	Divertículos, parede espessada, gordura densificada	0 ou Ia
1A	Bolhas de ar ou pouco líquido pericólico, sem abscesso	Ia
1B	Abscesso ≤ 4 cm	Ib se pericólico; II se pélvico
2A	Abscesso > 4 cm	Ib se pericólico; II se pélvico
2B	Ar distante (> 5 cm do segmento)	sem equivalente
3	Líquido difuso, sem ar livre distante	III ou IV
4	Líquido difuso com ar livre distante	III ou IV

Hinchey modificado (Wasvary 1999; Kaiser 2005) [7, 8]. Quadro WSES reconstruído de Fugazzola 2022, Fig. 1 (CC BY) [39]. A TC não separa pus de fezes.

Mensagem Hinchey Ib × II é local; WSES 1B × 2A é tamanho — e o tamanho volta no limiar.

Ref.: [5, 7, 8, 39]

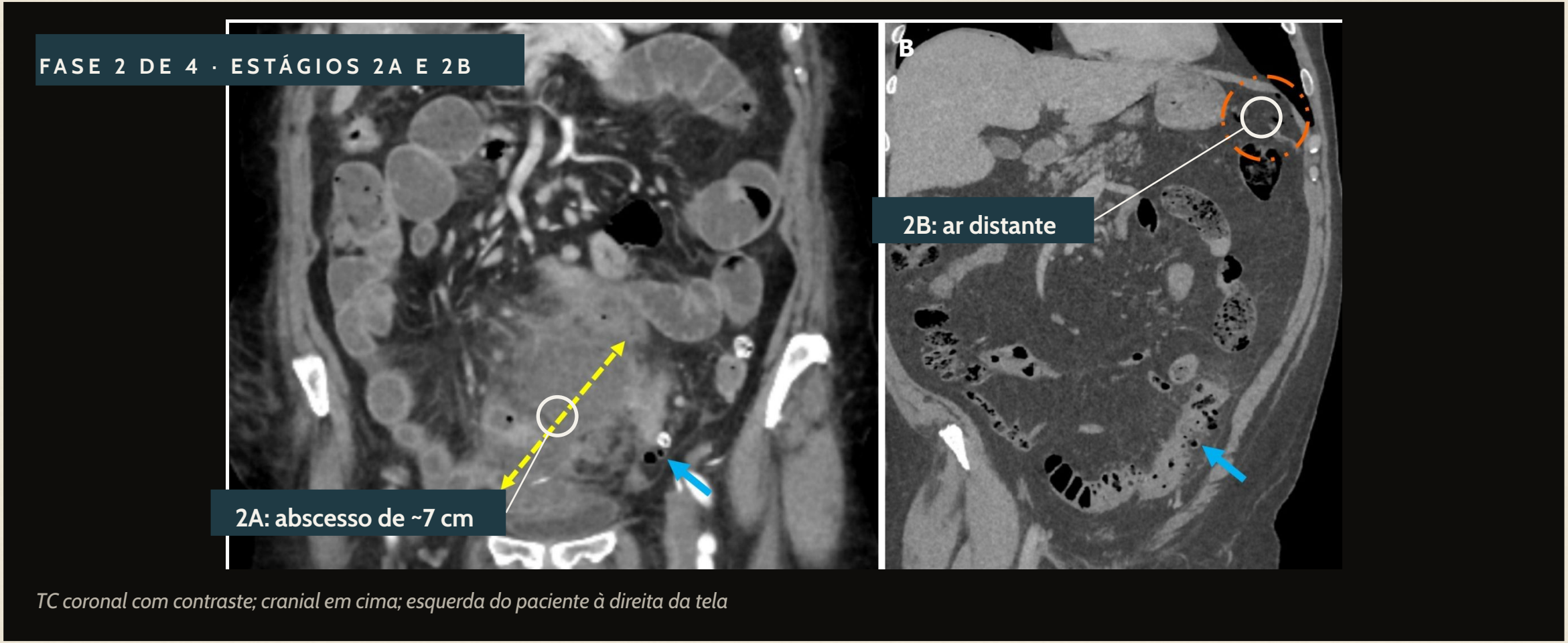
O exame: a TC com contraste mostra em que degrau o paciente está



TC axial com contraste; anterior em cima; esquerda do paciente à direita da tela

Fonte: Simsar et al., 2025 · Fig. 3 · CC BY-NC 4.0 · PMC12400287 · Ref.: [5]

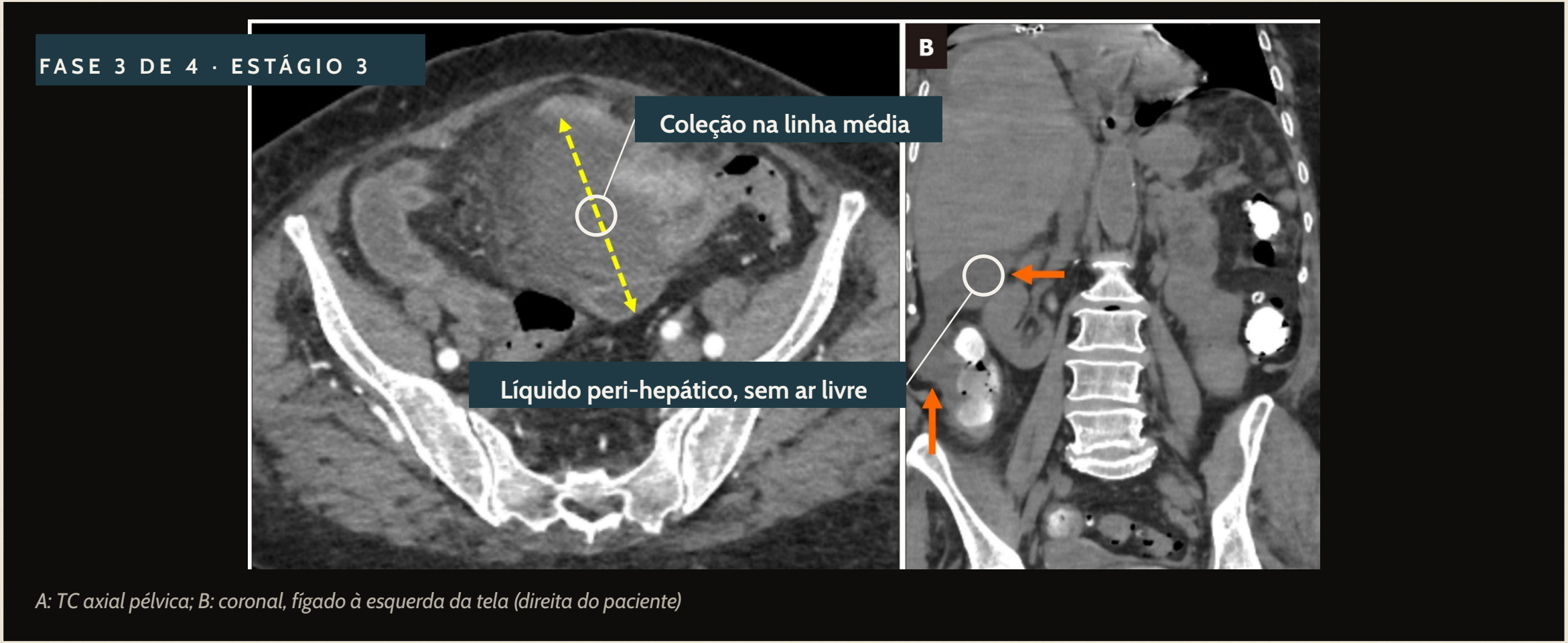
O exame: a TC com contraste mostra em que degrau o paciente está



TC coronal com contraste; cranial em cima; esquerda do paciente à direita da tela

Fonte: Simsar et al., 2025 · Fig. 4 · CC BY-NC 4.0 · PMC12400287 · Ref.: [5]

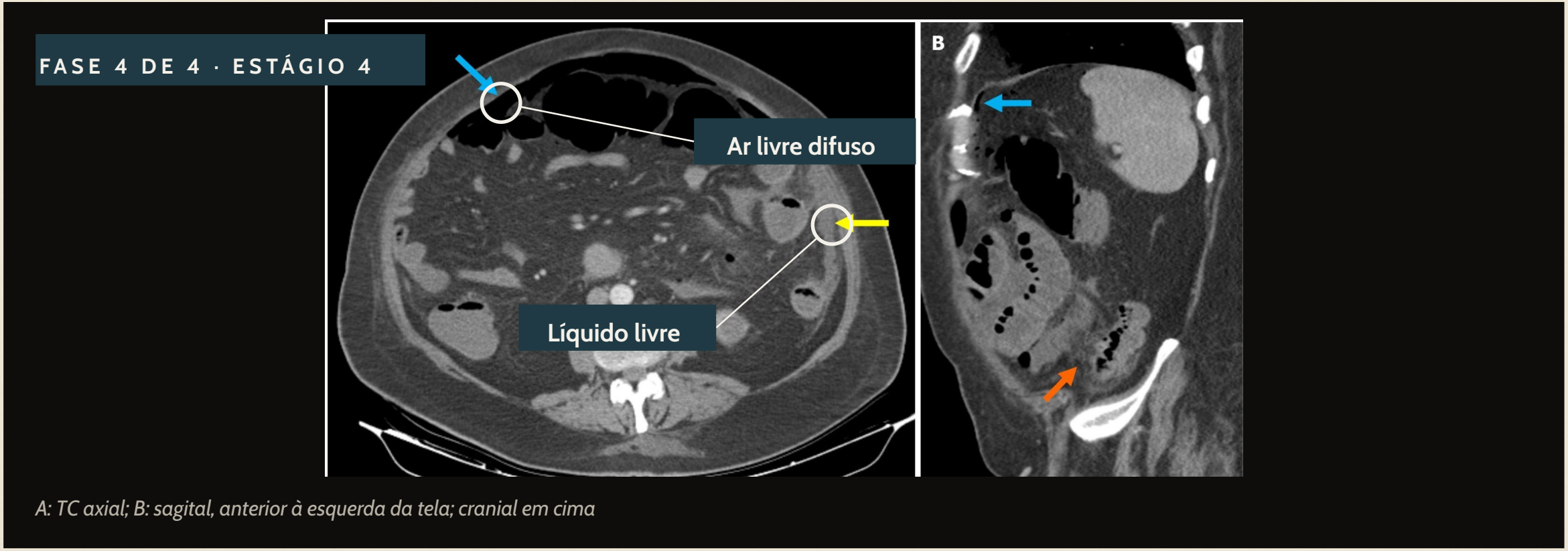
O exame: a TC com contraste mostra em que degrau o paciente está



A: TC axial pélvica; B: coronal, fígado à esquerda da tela (direita do paciente)

Fonte: Simsar et al., 2025 · Fig. 5 · CC BY-NC 4.0 · PMC12400287 · Ref.: [5]

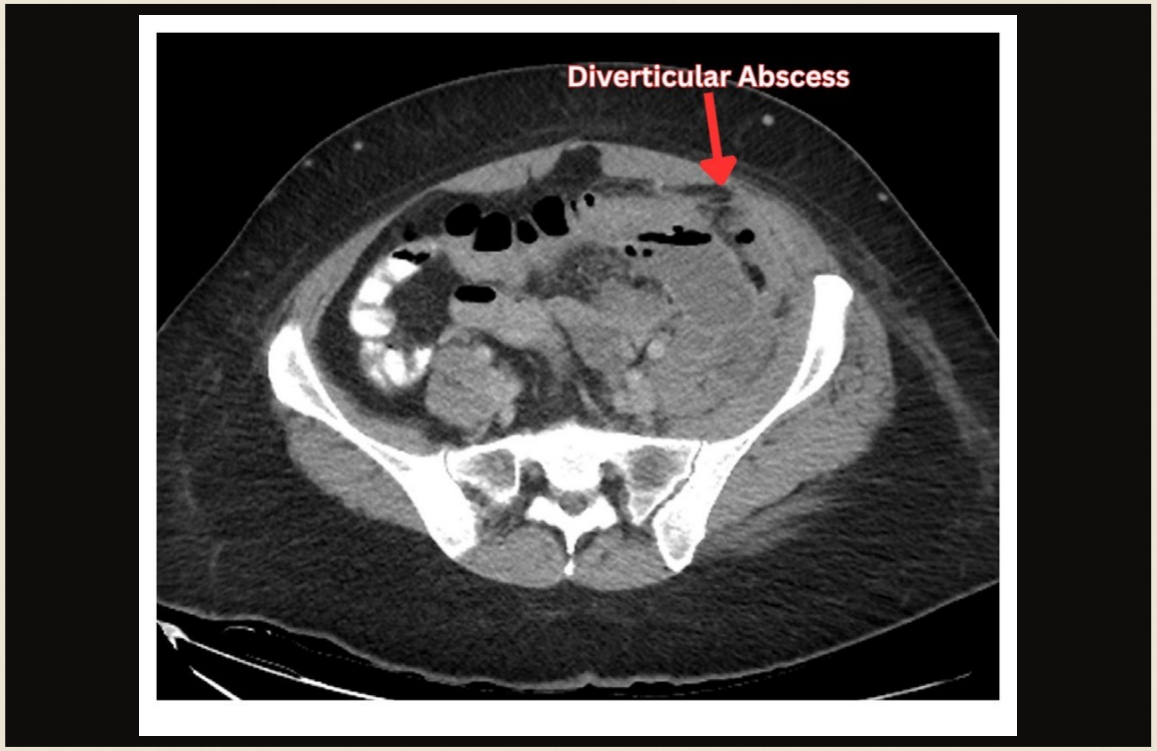
O exame: a TC com contraste mostra em que degrau o paciente está

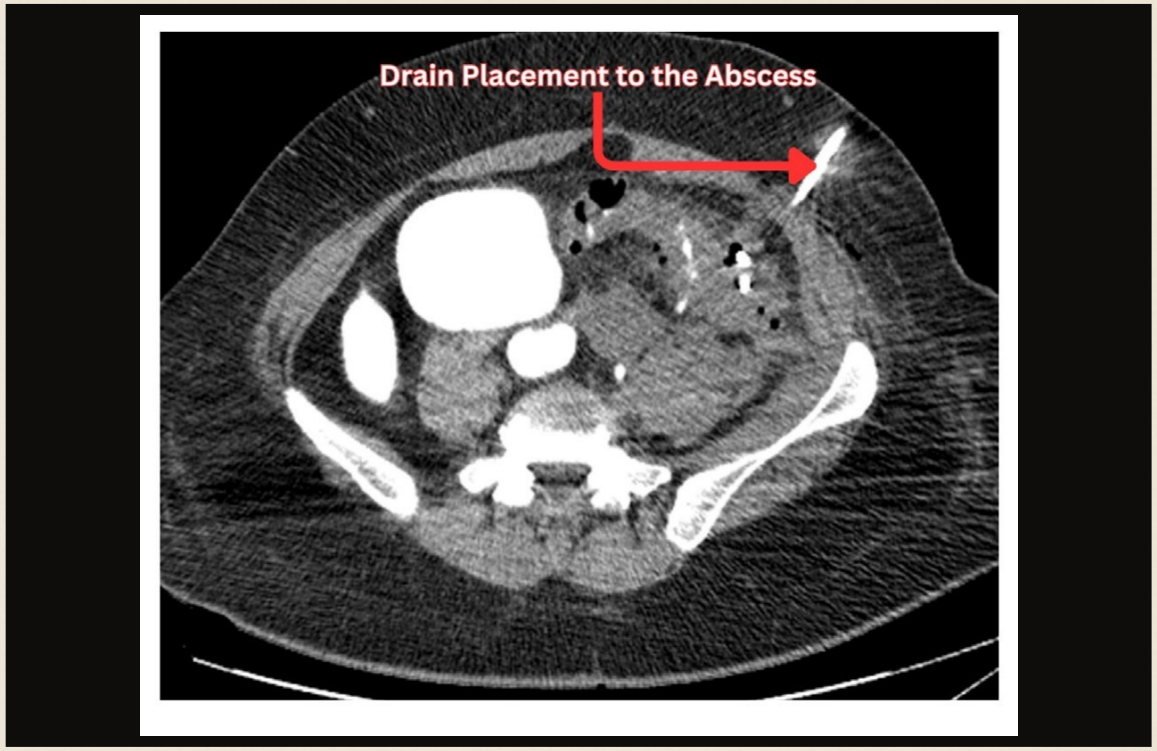


A: TC axial; B: sagital, anterior à esquerda da tela; cranial em cima

Mensagem 1B–2A: abscesso, antibiótico ou dreno; 3–4: peritonite, cirurgia [5].

O abscesso grande e acessível recebe um dreno pigtail guiado por TC





Rótulos em inglês impressos pelos autores; axial, esquerda do paciente à direita da tela

Mensagem Falha ≈ 20% com qualquer opção; 15,5% precisaram reposicionar o dreno [13].

Fonte: Usman et al., 2025 · Fig. 1, 2 · CC BY-NC 4.0 · PMC12313123 · rótulos dos autores · Ref.: [5, 13]

Divergência entre fontes: o limiar para drenar varia de 3 a 5 cm

Diretriz	Drenar acima de	Força ou observação
ASCRS 2020 [4]	3 cm	Forte, evidência moderada (1B)
DGVS/DGAV 2022, ESCP 2020, NICE [9]	3 cm	NICE: evidência muito baixa
EAES/SAGES 2018 [9]	4 cm	Citada na revisão guarda-chuva
SICCR 2015 [36]	≥ 4 cm (≤ 3 cm: antibiótico)	Grau 2A; Cirocchi a lista como > 5 cm
WSES 2020 [5]	4–5 cm	Fraca (2C), baseada em 5 estudos

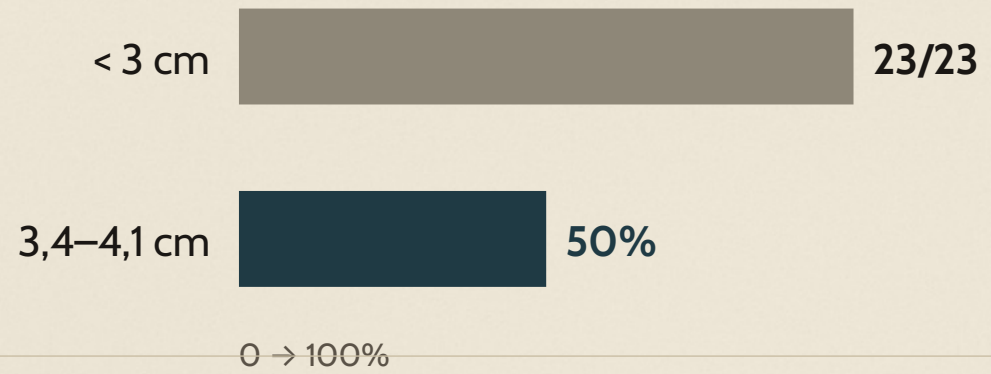
Sete diretrizes nem definem limiar; todas drenam, quando factível, a partir de 4–5 cm [9].

Mensagem O debate está em 3 cm; acima de 4–5 cm, todas concordam em drenar [9].

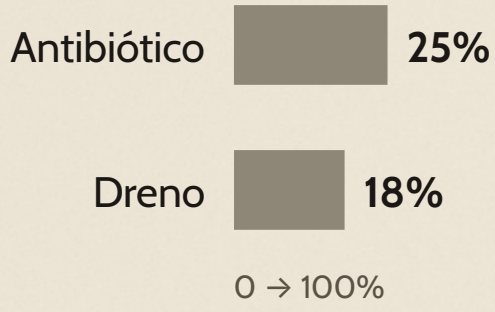
Ref.: [4, 5, 9, 36]

O limiar é consenso, não desfecho: metade dos abscessos de 3,4–4,1 cm resolveu sem dreno

Resolução só com antibiótico (Siewert) [10]



Cirurgia urgente, abscesso ≥ 3 cm (Elagili) [12]



p = 0,21

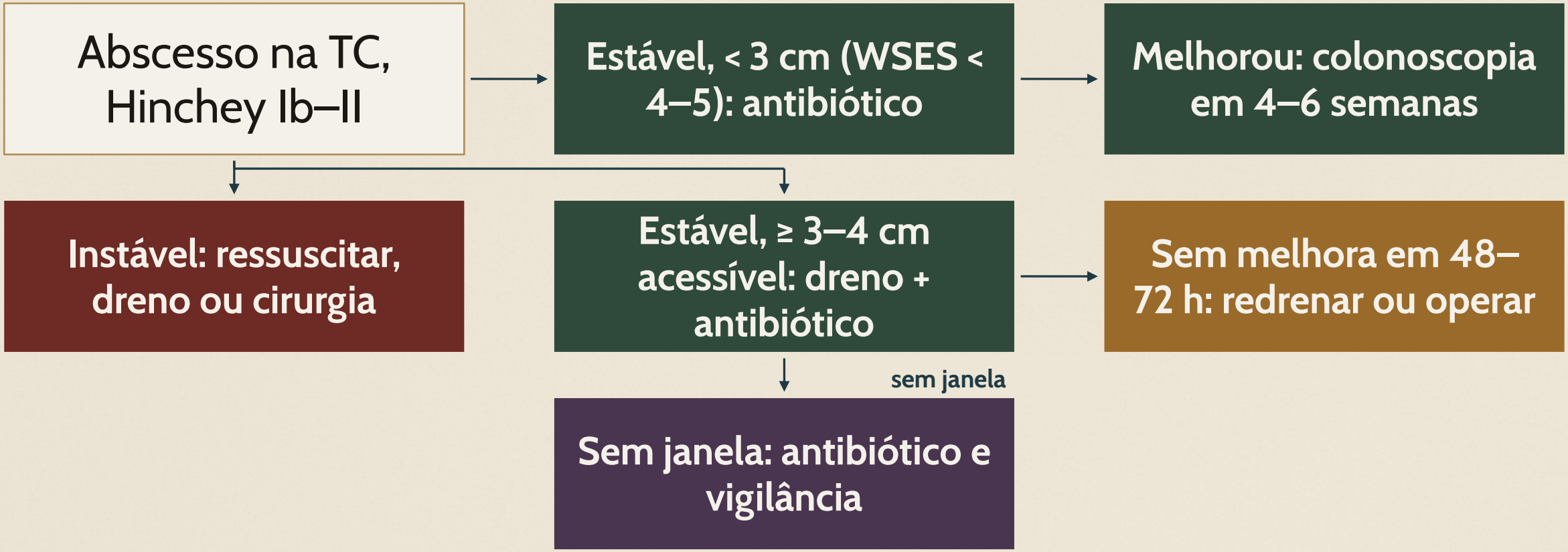
- Falha global de 16–22% com qualquer opção [13, 14]
- Kumar: falha acima de 6,5 cm e febre > 38,4 °C [11]
- Só estudos observacionais, sem ECR [9, 13]

MENSAGEM

O limiar é gatilho; quem julga é a resposta clínica.

Ref.: [9, 10, 11, 12, 13, 14]

Máquina de decisão: estabilidade, tamanho e janela de acesso definem antibiótico ou dreno



Mensagem Estrutura adaptada de Cirocchi 2021 [38]; números das fontes primárias.

Ref.: [4, 5, 10, 13, 38]

O caso: o abscesso pélvico de 5,5 cm com febre vai para o dreno

CASO DIDÁTICO · RETORNO

TC	Coleção pélvica de 5,5 cm, sem ar distante nem líquido difuso: Hinchey II / WSES 2A
CONDUTA	Drenagem guiada por TC + antibiótico para Gram-negativos e anaeróbios [4, 5]
EM 72 H	Afebril, débito caindo; TC de controle sem cavidade: dreno retirado [5]

E se ela não tivesse melhorado?

- Nova TC, redrenar ou reposicionar; em falha, cirurgia [5]
- Avisar antes: falha ≈ 20%; 15,5% ajustam o dreno [13]

Ref.: [4, 5, 13]

Sumário — onde estamos

1 Do divertículo à TC — CONCLUÍDA

2 Abscesso: antibiótico ou dreno — CONCLUÍDA

3 Peritonite purulenta e lavagem

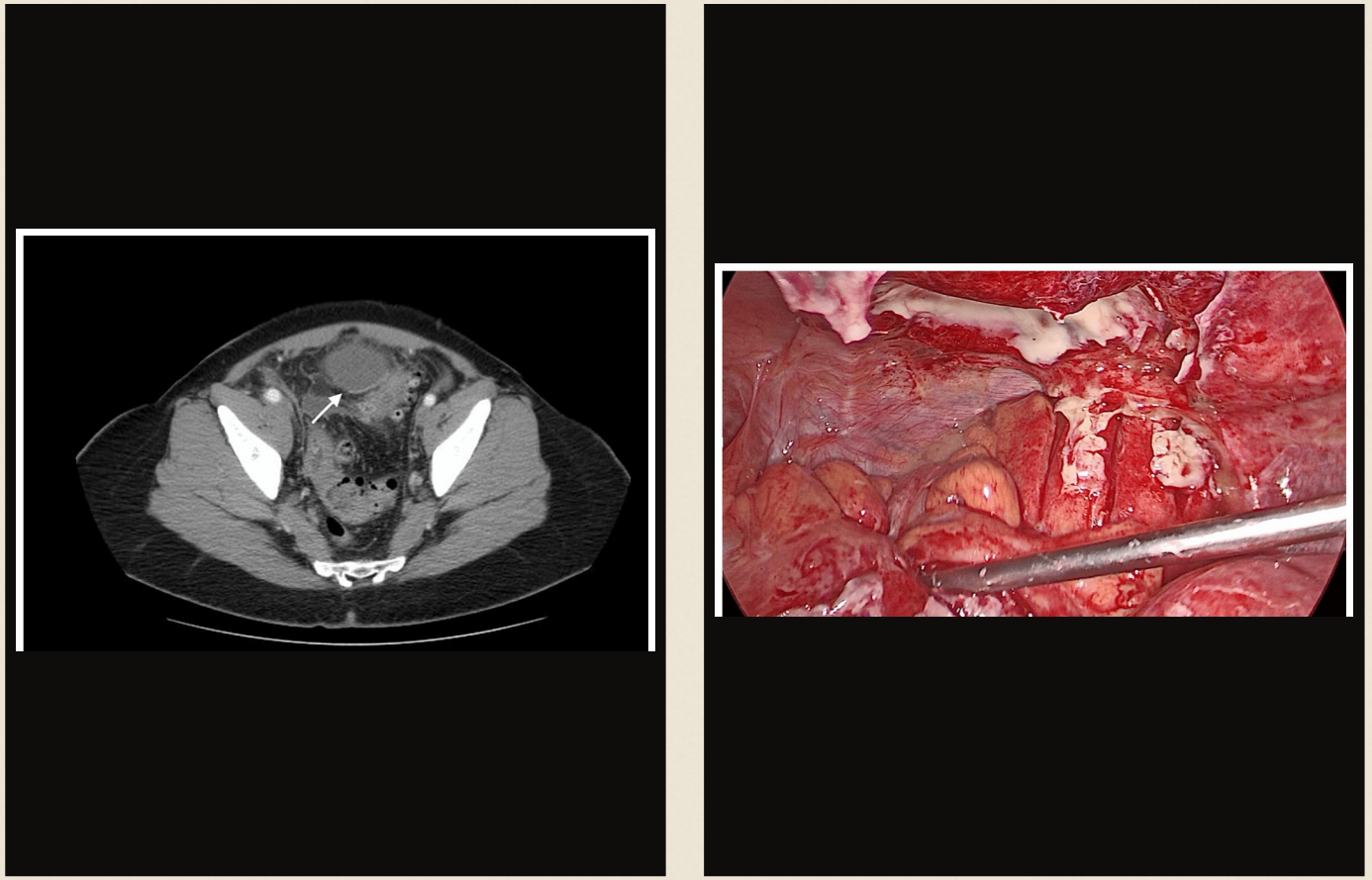
4 Anastomose primária ou Hartmann

5 Depois do abscesso

6 Respostas e forja

Mensagem Segunda metade: a peritonite, a escolha da operação e o seguimento.

Na mesa: lavar é aspirar o pus, lavar os quatro quadrantes e drenar, sem ressecar



Paciente de 31 anos com síndrome de Williams (relato de caso); TC e laparoscopia do mesmo paciente

- Soro aquecido até retorno claro: ≥ 3 L (DILALA), 6 L (LOLA) [21, 24]
- Só após confirmar Hinchey III na laparoscopia [22, 24]
- O sigmoide fica: 4 + 4 carcinomas não vistos [21, 22]

MENSAGEM

Ganha-se a ausência de estoma; o segmento doente fica no lugar.

Divergência entre fontes: a lavagem foi melhor que o Hartmann no DILALA e pior na LOLA e no SCANDIV

Estudo	Comparação	O que aconteceu com a lavagem
DILALA [24, 25]	× Hartmann aberto	Reoperação em 2 anos 18/43 × 27/40 (RR 0,55)
LOLA [20, 21]	× sigmoidectomia	Interrompido por eventos; 45% acabaram ressecados
SCANDIV [22, 23]	× ressecção primária	Reoperação 20,3% × 5,7%; recorrência 21% × 4%
Penna 2018 [26]	Metanálise, 589 pacientes	Abscesso OR 2,85; peritonite persistente OR 7,80
Huo 2025 [2]	Rede IPD × Hartmann	Estoma em 1 ano −244/1000; mortalidade +42/1000

Huo: certeza baixa; IC da mortalidade cruza o zero (−41 a +331/1000) [2].

Mensagem O comparador muda o veredito: Hartmann aberto no DILALA; ressecção nos outros [21, 22, 24].

Ref.: [2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26]

O caminho errado: lavar e drenar uma peritonite com pus fecal

CAMINHO ERRADO

"Laparoscopia com conteúdo fecal na pelve: lavar bem, deixar drenos e poupar o paciente do estoma."

O QUE ACONTECE

- Fora de todos os protocolos: o fecal era inelegível ou ressecado nos dois braços [22, 24]
- ASCRS: lavagem não recomendada na peritonite fecal (1A) [4]
- Mesmo no purulento, sepse não controlada levou a Hartmann de emergência em 6 pacientes da LOLA [21]

POR QUE ERRA

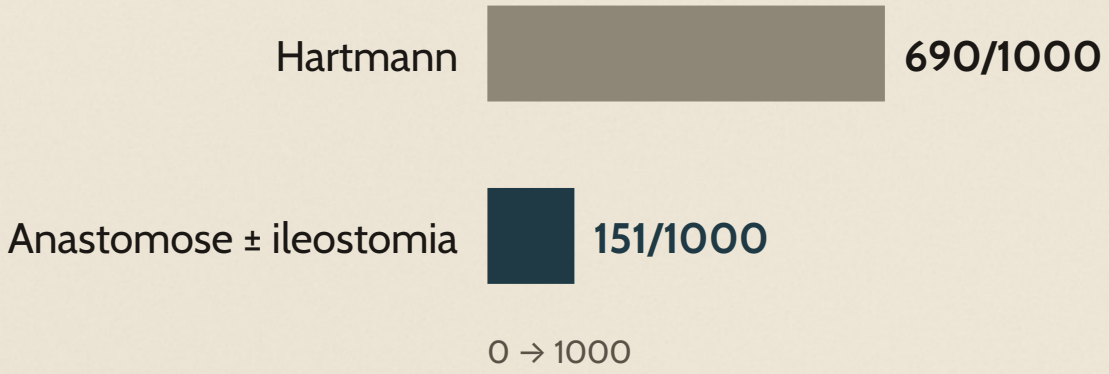
A lavagem só foi testada no Hinchey III confirmado na laparoscopia; no IV não há evidência a favor e a diretriz contraindica [4, 22, 24].

Mensagem Achou fezes, outra doença ou suspeita de câncer: abandone a lavagem e resseque.

Ref.: [4, 21, 22, 24]

A evidência: com anastomose primária, 151 em cada 1000 têm estoma em 1 ano; com Hartmann, 690

Estoma em 1 ano, por 1000 pacientes — rede IPD, 7 ECRs [2]



- −539/1000 (OR 0,08), certeza moderada [2]
- Mortalidade 30 dias 67 × 60/1000: sem diferença [2]
- Complicação maior 248 × 200/1000: sem diferença [2]
- Rede: 76% Hinchey III e só 2,2% Hinchey I–II [2]

O resumo de Huo atribui −539/1000 a PRA × lavagem; a Tabela 2 mostra que é PRA × Hartmann.

MENSAGEM

Mesmo risco imediato, quatro vezes menos estoma em 1 ano.

Ref.: [2]

A fonte: Huo 2025 — menos estoma com anastomose, sem diferença de mortalidade em 30 dias

1. Surg Endosc. 2025 Feb;39(2):699-715. doi: 10.1007/s00464-024-11457-8. Epub 2024 Dec 28.

Surgical management of complicated diverticulitis: systematic review and individual patient data network meta-analysis : An EAES/ESCP collaborative project.

Huo B(1), Ortenzi M(2), Anteby R(3)(4), Tryliskyy Y(5), Carrano FM(6), Seitidis G(7)(8), Mavridis D(7), Hoek VT(9), Serventi A(10), Bemelman WA(11), Binda GA(11)(12), Duran R(13), Doulias T(14)(15)(16), Forbes N(17)(18), Francis NK(19), Grass F(20), Jensen J(21), Krogsgaard M(22), Massey LH(23), Morelli L(24), Oberkofler CE(25)(26), Popa DE(27), Schultz JK(28)(29)(30), Sultan S(31), Tuech JJ(32), Bonjer HJ(33)(34), Antoniou SA(35)(36).

PRA likely confers a lower stoma rate at 1 year compared to HR, while there may be no difference in 30-day/in-hospital mortality. LPL likely confers a higher in-hospital/30-day mortality rate compared to HR and PRA.

TRADUÇÃO A anastomose primária provavelmente reduz a taxa de estomia em 1 ano em relação ao Hartmann, talvez sem diferença de mortalidade em 30 dias/intra-hospitalar; a lavagem laparoscópica provavelmente tem mortalidade intra-hospitalar/30 dias maior que Hartmann e anastomose primária (7 ECR, IPD de 595 pacientes; certeza baixa).

Fonte: Huo et al., Surg Endosc 2025 (IPD network meta-analysis EAES/ESCP) [2] · print do resumo no PubMed, marca-texto acrescentado

Hartmann × anastomose: a diferença está no estoma, e a força da recomendação diverge

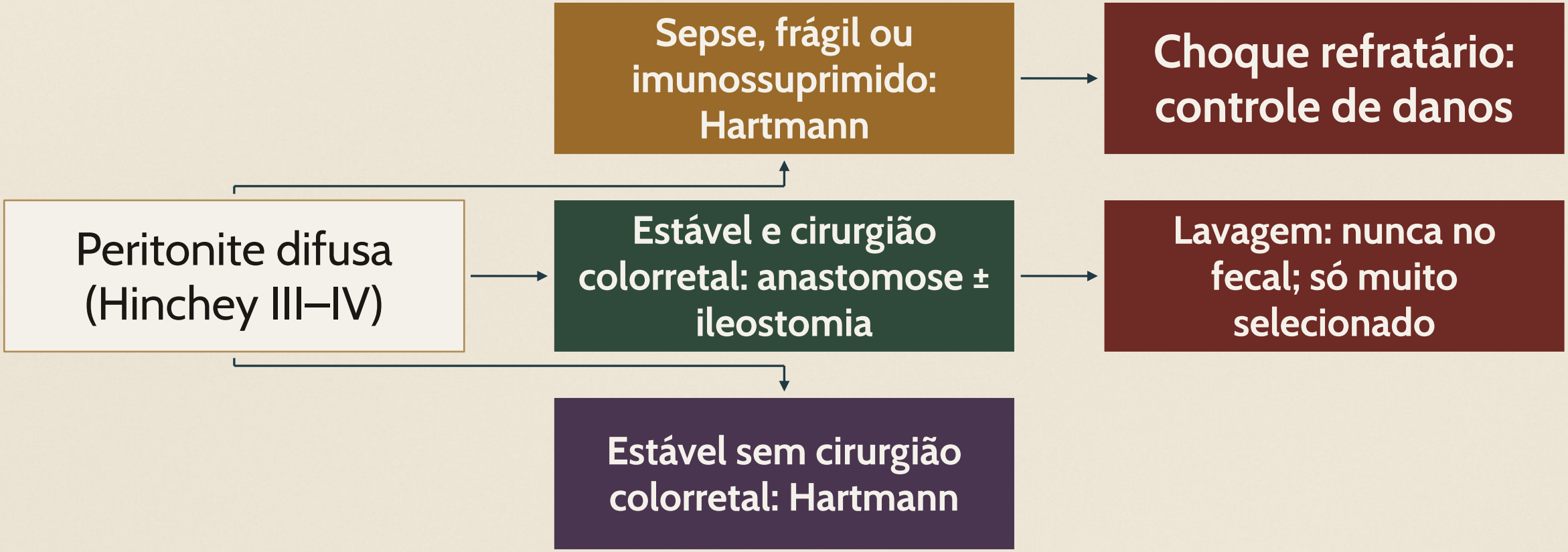
	Hartmann	Anastomose ± ileostomia
O que se faz	Ressecção, coto retal fechado, colostomia	Ressecção e anastomose; ileostomia opcional
Trânsito em 18 meses (DIVERTI) [28]	65%	96%
Livre de estoma em 12 meses (LADIES) [30]	71,7%	94,6%
Hérnia [29, 31]	Incisional 52%; paraestomal 16%	Incisional 29%; paraestomal 2%
Recomendação [1, 5]	WSES forte (2B) no crítico; EAES condicional (muito baixa)	WSES fraca (2B); EAES condicional (baixa)

Quadro nativo (sem figura aberta das duas operações). Nenhum ECR randomizou a ileostomia; no LADIES, 27% do braço anastomose ficou sem ela [30].

Mensagem Divergência: WSES forte × EAES condicional — faltam dados nesses subgrupos [1, 2, 5].

Ref.: [1, 5, 28, 29, 30, 31]

Máquina de decisão: sepse, fragilidade e cirurgião definem anastomose ou Hartmann



Mensagem EAES: a lavagem nunca é a opção sugerida [1]. Estrutura adaptada de Cirocchi 2021 [38].

Ref.: [1, 4, 5, 30, 38]

A fonte: EAES 2025 — anastomose sem sepse com cirurgião experiente; Hartmann em sépticos, frágeis e imunocomprometidos

1. Surg Endosc. 2025 Feb;39(2):673-686. doi: 10.1007/s00464-024-11445-y. Epub 2024 Dec 28.

EAES rapid guideline: surgical management of complicated diverticulitis - with ESCP participation.

Antoniou SA(1)(2), Huo B(3), Ortenzi M(4), Anteby R(5)(6), Tryliskyy Y(7), Carrano FM(8), Seitidis G(9), Mavridis D(9), Hoek VT(10), Serventi A(11), Bemelman WA(12), Binda GA(13), Duran R(14), Doulias T(15)(16)(17), Forbes N(18)(19), Francis NK(20), Grass F(21), Jensen J(22), Krogsgaard M(23), Massey LH(24), Morelli L(25), Oberkofler CE(26)(27), Popa DE(28), Schultz JK(29)(30)(31), Sultan S(32), Tuech JJ(33), Bonjer HJ(34)(35).

The panel suggests that patients with complicated diverticulitis without sepsis receive PRA over HR or LPL when there is availability of a surgeon with skills and experience in colorectal surgery. HR is suggested over PRA or LPL in the subgroups of septic, frail, as well as immunocompromised patients.

TRADUÇÃO O painel sugere ressecção com anastomose primária (PRA) em vez de Hartmann ou lavagem laparoscópica na diverticulite complicada sem sepse, quando houver cirurgião com experiência colorretal; Hartmann é sugerido em vez de PRA ou lavagem nos subgrupos sépticos, frágeis e imunocomprometidos.

Fonte: Antoniou et al., Surg Endosc 2025 (EAES rapid guideline) [1] · print do resumo no PubMed, marca-texto acrescentado

O caminho errado: Hartmann de rotina no paciente estável com cirurgião experiente

CAMINHO ERRADO

"60 anos, estável, imunocompetente, Hinchey III, cirurgião colorretal na sala: Hartmann por segurança."

O QUE ACONTECE

- Estoma em 1 ano: 690 × 151 por 1000 com anastomose [2]
- Trânsito reconstruído em 18 meses: 65% × 96% [28]
- Hérnia incisional 52% × 29%; paraestomal 16% × 2% [29, 31]
- 20–50% dos Hartmann nunca revertem [37]

POR QUE ERRA

Nesse perfil, mortalidade em 30 dias e complicação maior não diferem: o Hartmann não compra segurança, só estoma [2].

Mensagem No estável com cirurgião experiente, Hartmann é a exceção, não a rotina.

Ref.: [2, 28, 29, 31, 37]

Divergência entre fontes: depois do abscesso, a eletiva vai de "considerar" a "observar"

Fonte	Posição	O número por trás
ASCRS 2020 [4]	Eletiva "should typically be considered" (1B)	Recorrência 25–28% sem cirurgia [13, 17]
Kaiser 2005 [8]	"Strongly consider" a eletiva	Abscesso pélvico: recorrência 41,2%
WSES 2020 [5]	Individualizar por fatores do paciente (2D)	Imunossuprimido: mortalidade de urgência 31,6%
Aquina 2019 [18]	Observar é razoável	10.342 pacientes: recorrência 24,8% em 5 anos; eletiva com mais estoma, 10,0% × 5,7%
LASER, 4 anos [35]	Cirurgia se a qualidade de vida é ruim	Recorrência 16% × 92%; qualidade de vida igual

Ambrosetti: 58% dos mesocólicos tratados com sucesso nunca precisaram de cirurgia × 47% dos pélvicos [16].

> **Mensagem** Favorecem a eletiva: abscesso pélvico, imunossupressão, sintomas persistentes, dúvida de câncer [4, 5, 16].

Ref.: [4, 5, 8, 13, 16, 17, 18, 35]

O caso: abscesso pélvico resolvido — colonoscopia e decisão compartilhada sobre a eletiva

CASO DIDÁTICO · DESFECHO

4–6 SEMANAS	Colonoscopia: 11,4% dos abscessos escondiam câncer [5]
CONTRA A ELETIVA	Recorrência 24,8% em 5 anos; eletiva com mais estoma [18]
A FAVOR	Pélvico: recorrência até 41,2%; 71% operados no seguimento [8, 16]

E se ela chegasse com peritonite purulenta difusa?

- Estável: sigmoidectomia + anastomose ± ileostomia [1, 2]
- Choque séptico ou corticoide: Hartmann [1, 5]

Ref.: [1, 2, 5, 8, 16, 18]

Pergunta 1: o tamanho orienta, mas a estabilidade e a resposta decidem

1 PERGUNTA-BÚSSOLA

Em abscesso diverticular Hinchey Ib–II, quais achados justificam antibióticos isolados versus drenagem percutânea, e quão confiável é o limiar de 3–4 cm?

- Antibiótico: estável, < 3 cm (WSES < 4–5 cm) [4, 5]
- Dreno: maior e acessível, febre, pélvico; distante falha 51% × 18% [4, 15, 16]
- Limiar pouco confiável: 50% de 3,4–4,1 cm resolveram; 25% × 18% (p = 0,21) [10, 12]

VEREDITO

Antibiótico no pequeno e estável; dreno no grande e acessível. O limiar é gatilho, não regra.

Ref.: [4, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16]

Pergunta 2: lavagem só no Hinchey III confirmado e selecionado, e com critério para abandonar

2 PERGUNTA-BÚSSOLA

Em peritonite purulenta, quando a lavagem laparoscópica é aceitável e quais critérios devem fazê-la ser abandonada?

- Aceitável: Hinchey III confirmado, estável, imunocompetente, sem suspeita de câncer [5, 20, 24]
- Custo: reoperação 20,3% × 5,7%; recorrência 21% × 4% [22, 23]
- Abandonar: fezes, sepse ou instabilidade, outra doença, sepse que persiste [1, 4, 21]

VEREDITO

Exceção muito selecionada, não primeira linha; a EAES nunca a sugere.

Ref.: [1, 2, 4, 5, 20, 21, 22, 23]

Pergunta 3: três perguntas escolhem a operação — sepse, fragilidade e cirurgião

3 PERGUNTA-BÚSSOLA

Como selecionar entre anastomose primária, com ou sem ileostomia de proteção, e procedimento de Hartmann?

- Estável, imunocompetente, < 85 anos, cirurgião colorretal: anastomose ± ileostomia [1, 30]
- Estoma em 1 ano 151 × 690/1000, mesma mortalidade [2]; trânsito 96% × 65% [28]
- Sepse, frágil, imunossuprimido ou sem cirurgião experiente: Hartmann [1, 5]

VEREDITO

Anastomose ± ileostomia como padrão no estável; Hartmann quando a fisiologia ou a equipe não permitem.

Ref.: [1, 2, 5, 28, 30]

Pergunta 4: a eletiva após abscesso é individualizada, mas a colonoscopia é rotina

4 PERGUNTA-BÚSSOLA

Após resolução não operatória de abscesso, a ressecção eletiva deve ser rotineira ou individualizada?

- Sempre: colonoscopia em 4–6 semanas [5]
- Sem cirurgia, recorrência 25–28%; eletiva traz mais estoma na população [17, 18]
- Favorecem operar: pélvico, imunossupressão, sintomas, qualidade de vida ruim [4, 5, 16, 35]

VEREDITO

Individualizada, com viés para oferecer no pélvico e no imunossuprimido.

Ref.: [4, 5, 13, 16, 17, 18, 35]

Forja 1 — o abscesso pequeno

Homem de 55 anos, imunocompetente, estável, com dor em fossa ilíaca esquerda há 2 dias. TC: sigmoide espessado e abscesso pericólico de 2,5 cm, sem ar distante nem líquido livre (Hinchey Ib). A conduta inicial mais adequada é:

A. Drenagem percutânea guiada por TC e antibiótico

B. Sigmoidectomia de urgência com anastomose primária

C. Lavagem laparoscópica e drenagem da cavidade

D. Antibiótico isolado contra Gram-negativos e anaeróbios, com reavaliação

E. Colonoscopia na internação para excluir câncer

Antes de avançar: qual é o dado que decide a questão?

Forja 1 — o abscesso pequeno

Homem de 55 anos, imunocompetente, estável, com dor em fossa ilíaca esquerda há 2 dias. TC: sigmoide espessado e **abscesso pericólico de 2,5 cm**, sem ar distante nem líquido livre (Hinchey Ib). A conduta inicial mais adequada é:

A. Drenagem percutânea guiada por TC e antibiótico

B. Sigmoidectomia de urgência com anastomose primária

C. Lavagem laparoscópica e drenagem da cavidade

D. Antibiótico isolado contra Gram-negativos e anaeróbios, com reavaliação

E. Colonoscopia na internação para excluir câncer

GABARITO D · COMENTÁRIO

Abaixo de 3 cm, o abscesso resolve com antibiótico (23/23 em Siewert) e a drenagem é tecnicamente difícil [9, 10]; dreno é para ≥ 3–4 cm acessível [4, 5]; colonoscopia só em 4–6 semanas [5].

Forja 2 — a peritonite purulenta

Mulher de 58 anos, imunocompetente, estável sem vasopressor, com peritonite difusa. Laparoscopia: pus nos quatro quadrantes, sem fezes (Hinchey III). Há cirurgião com experiência colorretal na equipe. Pela EAES 2025, a conduta sugerida é:

A	Sigmoidectomia com anastomose primária ± ileostomia de proteção
B	Procedimento de Hartmann
C	Lavagem laparoscópica sem ressecção
D	Colostomia em alça sem ressecção
E	Drenagem percutânea e antibiótico

Antes de avançar: qual é o dado que decide a questão?

Forja 2 — a peritonite purulenta

Mulher de 58 anos, imunocompetente, estável sem vasopressor, com peritonite difusa. Laparoscopia: pus nos quatro quadrantes, sem fezes (Hinchey III). **Há cirurgião com experiência colorretal na equipe**. Pela EAES 2025, a conduta sugerida é:

A	**Sigmoidectomia com anastomose primária ± ileostomia de proteção**
B	Procedimento de Hartmann
C	Lavagem laparoscópica sem ressecção
D	Colostomia em alça sem ressecção
E	Drenagem percutânea e antibiótico

GABARITO A · COMENTÁRIO

Sem sepse e com cirurgião colorretal, a EAES sugere anastomose primária ± ileostomia: estoma em 1 ano 151 × 690/1000, mesma mortalidade [1, 2]. Hartmann fica para sepse, fragilidade, imunossupressão ou falta desse cirurgião [1].

Questão didática construída a partir das fontes citadas · Ref.: [1, 2, 30]

Forja 3 — depois do dreno

Mulher de 60 anos teve abscesso pélvico de 6 cm drenado por via percutânea, com resolução completa. Está assintomática há 4 semanas e nunca fez colonoscopia. A conduta mais adequada é:

A Alta sem seguimento, porque o abscesso resolveu

B Sigmoidectomia obrigatória, indicada para todos após abscesso

C Colonoscopia e discussão individualizada de sigmoidectomia eletiva laparoscópica

D Aguardar um segundo episódio para indicar a cirurgia

Antes de avançar: qual é o dado que decide a questão?

Forja 3 — depois do dreno

Mulher de 60 anos teve **abscesso pélvico de 6 cm** drenado por via percutânea, com resolução completa. Está assintomática há 4 semanas e nunca fez colonoscopia. A conduta mais adequada é:

A Alta sem seguimento, porque o abscesso resolveu

B Sigmoidectomia obrigatória, indicada para todos após abscesso

C Colonoscopia e discussão individualizada de sigmoidectomia eletiva laparoscópica

D Aguardar um segundo episódio para indicar a cirurgia

GABARITO C · COMENTÁRIO

Colonoscopia em 4–6 semanas (câncer em 11,4% dos abscessos) [5]; eletiva "deve ser considerada" (ASCRS 1B) e individualizada, sem contar episódios (WSES) [4, 5]; o pélvico recorre até 41,2% [8].

Tabela-mãe: gatilho → conduta

Suspeita de diverticulite

TC com contraste; US ou RM se indisponível [4, 5]

Gás pericólico ou fleimão (1A)

Antibiótico, tratamento não operatório [5]

Abscesso < 3 cm, estável

Antibiótico isolado [4, 5, 10]

Abscesso ≥ 3–4 cm acessível

Dreno percutâneo + antibiótico [4, 5, 9]

Sem melhora em 48–72 h

Nova TC, redrenar, operar [5, 11, 13]

Abscesso tratado sem cirurgia

Colonoscopia em 4–6 semanas [4, 5]

Abscesso resolvido

Eletiva individualizada [4, 5, 18]

Peritonite, estável, cirurgião colorretal

Anastomose ± ileostomia [1, 2, 30]

Sepse, frágil ou imunossuprimido

Hartmann [1, 5]

Extremo fisiológico

Controle de danos; 2° tempo em 24–48 h [5]

Peritonite fecal

Ressecar; lavagem contraindicada [4, 22]

"Lavar para evitar estoma"

Só muito selecionado; não é 1ª linha [1, 4, 26]

Ref.: [1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 18, 22, 26, 30]

Cinco mensagens resumem a aula

1. **Classificar:** a TC define o degrau, WSES ou Hinchey, e o degrau sugere a ferramenta [5].
2. **Abscesso:** antibiótico no pequeno, dreno no grande e acessível; o limiar de 3–5 cm é consenso, não desfecho [4, 5, 9].
3. **Lavagem:** não é primeira linha: menos estoma, à custa de reoperação, abscesso e câncer não visto [2, 21, 22].
4. **Peritonite:** anastomose ± ileostomia no estável com cirurgião experiente; Hartmann na sepse, fragilidade e imunossupressão [1, 2].
5. **Depois:** colonoscopia sempre; eletiva individualizada [4, 5, 18].

Mensagem A gravidade escolhe a ferramenta; a resposta ao tratamento decide o passo seguinte.

Ref.: [1, 2, 4, 5, 9, 18, 21, 22]

Referências citadas (33)

1. Antoniou SA, et al. EAES rapid guideline: surgical management of complicated diverticulitis – with ESCP participation. Surg Endosc. 2025;39(2):673-86. PMID 39733172.
2. Huo B, et al. Surgical management of complicated diverticulitis: systematic review and individual patient data network meta-analysis: An EAES/ESCP collaborative project. Surg Endosc. 2025;39(2):699-715. PMID 39733170.
3. Carabotti M, et al. Italian guidelines for the diagnosis and management of colonic diverticulosis and diverticular disease. Dig Liver Dis. 2024;56(12):1989-2003. PMID 39004551.
4. Hall J, et al. The American Society of Colon and Rectal Surgeons clinical practice guidelines for the treatment of left-sided colonic diverticulitis. Dis Colon Rectum. 2020;63(6):728-47. PMID 32384404.
5. Sartelli M, et al. 2020 update of the WSES guidelines for the management of acute colonic diverticulitis in the emergency setting. World J Emerg Surg. 2020;15(1):32. PMID 32381121.
7. Wasvary H, et al. Same hospitalization resection for acute diverticulitis. Am Surg. 1999;65(7):632-5. PMID 10399971.
8. Kaiser AM, et al. The management of complicated diverticulitis and the role of computed tomography. Am J Gastroenterol. 2005;100(4):910-7. PMID 15784040.
9. Cirocchi R, et al. Guidelines for the treatment of abdominal abscesses in acute diverticulitis: an umbrella review. J Clin Med. 2023;12(17):5522. PMID 37685590.
10. Siewert B, et al. Impact of CT-guided drainage in the treatment of diverticular abscesses: size matters. AJR Am J Roentgenol. 2006;186(3):680-6. PMID 16498095.
11. Kumar RR, et al. Factors affecting the successful management of intra-abdominal abscesses with antibiotics and the need for percutaneous drainage. Dis Colon Rectum. 2006;49(2):183-9. PMID 16322960.
12. Elagili F, et al. Antibiotics alone instead of percutaneous drainage as initial treatment of large diverticular abscess. Tech Coloproctol. 2015;19(2):97-103. PMID 25417122.
13. Gregersen R, et al. Treatment of patients with acute colonic diverticulitis complicated by abscess formation: a systematic review. Int J Surg. 2016;35:201-8. PMID 27741423.
14. Fowler H, et al. Failure of nonoperative management in patients with acute diverticulitis complicated by abscess: a systematic review. Int J Colorectal Dis. 2021;36(7):1367-83. PMID 33677750.
15. Lee H, et al. Systematic review of failure of nonoperative management in complicated sigmoid diverticulitis with abscess. Langenbecks Arch Surg. 2020;405(3):277-81. PMID 32323008.
16. Ambrosetti P, et al. Long-term outcome of mesocolic and pelvic diverticular abscesses of the left colon: a prospective study of 73 cases. Dis Colon Rectum. 2005;48(4):787-91. PMID 15747071.
17. Lamb MN, Kaiser AM. Elective resection versus observation after nonoperative management of complicated diverticulitis with abscess: a systematic review and meta-analysis. Dis Colon Rectum. 2014;57(12):1430-40. PMID 25380010.
18. Aquina CT, et al. Population-based study of outcomes following an initial acute diverticular abscess. Br J Surg. 2019;106(4):467-76. PMID 30335195.
20. Vennix S, et al. Laparoscopic peritoneal lavage or sigmoidectomy for perforated diverticulitis with purulent peritonitis: a multicentre, parallel-group, randomised, open-label trial. Lancet. 2015;386(10000):1269-77. PMID 26209030.
21. Hoek VT, et al. Laparoscopic peritoneal lavage versus sigmoidectomy for perforated diverticulitis with purulent peritonitis: three-year follow-up of the randomised LOLA trial. Surg Endosc. 2022;36(10):7764-74. PMID 35606544.
22. Schultz JK, et al. Laparoscopic lavage vs primary resection for acute perforated diverticulitis: the SCANDIV randomized clinical trial. JAMA. 2015;314(13):1364-75. PMID 26441181.
23. Azhar N, et al. Laparoscopic lavage vs primary resection for acute perforated diverticulitis: long-term outcomes from the Scandinavian Diverticulitis (SCANDIV) randomized clinical trial. JAMA Surg. 2021;156(2):121-7. PMID 33355658.
24. Angenete E, et al. Laparoscopic lavage is feasible and safe for the treatment of perforated diverticulitis with purulent peritonitis: the first results from the randomized controlled trial DILALA. Ann Surg. 2016;263(1):117-22. PMID 25489672.
25. Kohl A, et al. Two-year results of the randomized clinical trial DILALA comparing laparoscopic lavage with resection as treatment for perforated diverticulitis. Br J Surg. 2018;105(9):1128-34. PMID 29663316.
26. Penna M, et al. Laparoscopic lavage versus primary resection for acute perforated diverticulitis: review and meta-analysis. Ann Surg. 2018;267(2):252-8. PMID 28338510.
28. Bridoux V, et al. Hartmann's procedure or primary anastomosis for generalized peritonitis due to perforated diverticulitis: a prospective multicenter randomized trial (DIVERTI). J Am Coll Surg. 2017;225(6):798-805. PMID 28943323.
29. Loire M, et al. Long-term outcomes of Hartmann's procedure versus primary anastomosis for generalized peritonitis due to perforated diverticulitis: follow-up of a prospective multicenter randomized trial (DIVERTI). Int J Colorectal Dis. 2021;36(10):2159-64. PMID 34086087.
30. Lambrichts DPV, et al. Hartmann's procedure versus sigmoidectomy with primary anastomosis for perforated diverticulitis with purulent or faecal peritonitis (LADIES): a multicentre, parallel-group, randomised, open-label, superiority trial. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2019;4(8):599-610. PMID 31178342.
31. Edomskis PP, et al. Hartmann's procedure versus sigmoidectomy with primary anastomosis for perforated diverticulitis with purulent or fecal peritonitis: three-year follow-up of a randomised controlled trial. Int J Surg. 2022;98:106221. PMID 35026462.
35. Santos A, et al. Sigmoid resection vs conservative treatment after diverticulitis: prespecified 4-year analysis of the LASER randomized clinical trial. JAMA Surg. 2025;160(6):615-22. PMID 40202724.
36. Binda GA, et al. Practice parameters for the treatment of colonic diverticular disease: Italian Society of Colon and Rectal Surgery (SICCR) guidelines. Tech Coloproctol. 2015;19(10):615-26. PMID 26377584.
37. Hawkins AT, et al. Diverticulitis: an update from the age old paradigm. Curr Probl Surg. 2020;57(10):100862. PMID 33077029.
38. Cirocchi R, et al. State-of-the-art surgery for sigmoid diverticulitis. Langenbecks Arch Surg. 2021;407(1):1-14. PMID 34557938.
39. Fugazzola P, et al. The WSES/SICG/ACOI/SICUT/AcEMC/SIFIPAC guidelines for diagnosis and treatment of acute left colonic diverticulitis in the elderly. World J Emerg Surg. 2022;17:5. PMID 35063008.

Vancouver; numeração idêntica à dos slides e das notas.

Fontes das figuras (9)

F1 — Anaya-Prado R, Avalos-Herrera VJ, Silva-Esparza AA, et al. Jejunal diverticular disease: a gastrointestinal bleeding enigma. World J Gastrointest Pathophysiol. 2025;16(3):109103. Fig. 1 (recorte do painel central; divertículo jejunal, mesmo mecanismo do sigmoide). CC BY-NC 4.0. PMC12476669. doi:10.4291/wjgp.v16.i3.109103

F2 — Simsar M, Yuruk YY, Sahin O, et al. Radiological insights into diverticulitis: clinical manifestations, complications, and differential diagnosis. World J Radiol. 2025;17(8):107463. Fig. 3 (estágios 1A e 1B). CC BY-NC 4.0. PMC12400287. doi:10.4329/wjr.v17.i8.107463

F3 — Simsar M, Yuruk YY, Sahin O, et al. Radiological insights into diverticulitis: clinical manifestations, complications, and differential diagnosis. World J Radiol. 2025;17(8):107463. Fig. 4 (estágios 2A e 2B). CC BY-NC 4.0. PMC12400287. doi:10.4329/wjr.v17.i8.107463

F4 — Simsar M, Yuruk YY, Sahin O, et al. Radiological insights into diverticulitis: clinical manifestations, complications, and differential diagnosis. World J Radiol. 2025;17(8):107463. Fig. 5 (estágio 3). CC BY-NC 4.0. PMC12400287. doi:10.4329/wjr.v17.i8.107463

F5 — Simsar M, Yuruk YY, Sahin O, et al. Radiological insights into diverticulitis: clinical manifestations, complications, and differential diagnosis. World J Radiol. 2025;17(8):107463. Fig. 6 (estágio 4). CC BY-NC 4.0. PMC12400287. doi:10.4329/wjr.v17.i8.107463

F6 — Usman O, Imtiaz A, Basit MA, et al. Diverticular abscess and percutaneous drainage outcomes: a review of clinical practice for the primary team. J Community Hosp Intern Med Perspect. 2025;15(3):30-7. Fig. 1 (rótulos em inglês impressos pelos autores). CC BY-NC 4.0. PMC12313123. doi:10.55729/2000-9666.1474

F7 — Usman O, Imtiaz A, Basit MA, et al. J Community Hosp Intern Med Perspect. 2025;15(3):30-7. Fig. 2 (dreno pigtail 10 Fr guiado por TC; rótulos dos autores). CC BY-NC 4.0. PMC12313123. doi:10.55729/2000-9666.1474

F8 — Tsaramanidis SC, Gkoutziotis I, Zacharioudakis G, et al. Hinchey III diverticulitis in a 31-year-old patient with Williams syndrome: a case report. Cureus. 2024;16(7):e63898. Fig. 2 (TC; paciente de 31 anos com síndrome de Williams). CC BY 4.0. PMC11298154. doi:10.7759/cureus.63898

F9 — Tsaramanidis SC, Gkoutziotis I, Zacharioudakis G, et al. Cureus. 2024;16(7):e63898. Fig. 4 (lavagem laparoscópica, Hinchey III; mesmo paciente da Fig. 2). CC BY 4.0. PMC11298154. doi:10.7759/cureus.63898